



BUKU SAKU AKREDITASI

RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TK. III NGANJUK



(0358) 321896



rumkit.bhayangkara.nganjuk@gmail.com



www.rsbbhayangkaranganjuk.com



Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk



Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk



Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk

VISI & MISI

VISI

Mewujudkan Rumah Sakit yang Profesional untuk Mendukung Tugas Pokok Kepolisian dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat

MISI

1. Menyelenggarakan Kesehatan Kepolisian yang Profesional untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Polri;
2. Menyelenggarakan Dokpol untuk Mendukung Tugas Pokok Kepolisian;
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien serta Fasilitas Kesehatan;
4. Memberikan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Secara Prima dan Paripurna.

MOTTO

MATTA HATI

(Mahir, Cermat, Tanggap, dan Sepenuh Hati)

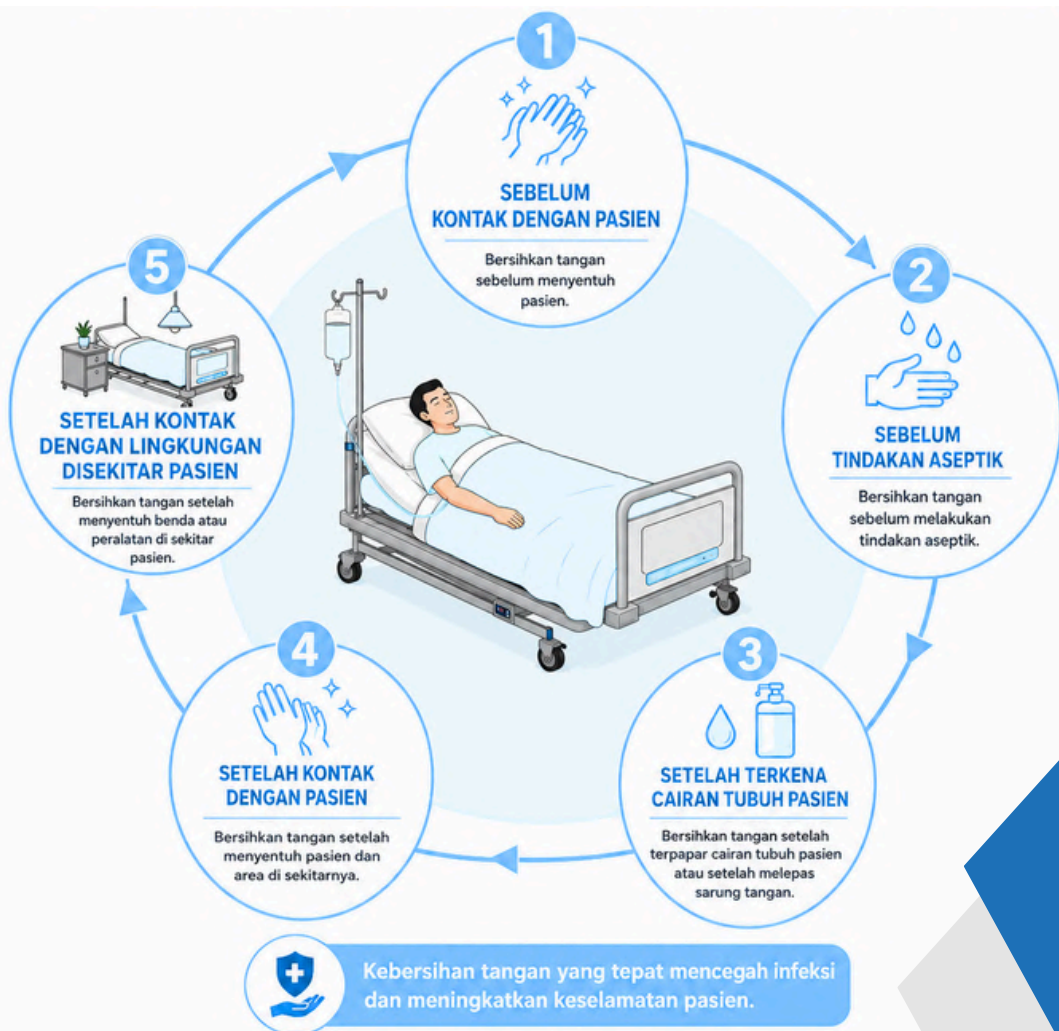
4S PLUS S

Senyum, Salam, Sapa, Sopan Plus Sabar

5 MOMEN CUCI TANGAN

5 MOMEN KEBERSIHAN TANGAN

LINDUNGI PASIEN, LINDUNGI DIRI, CEGAH INFEKSI



CARA MENCUCI TANGAN

CARA HAND RUB

DENGAN BERBAHAN DASAR ALKOHOL



1a



1b



Ambil secukupnya

CARA CUCI TANGAN

DENGAN BERBAHAN DASAR SABUN



1a



1b



Basahi Tangan dengan
Air Mengalir

Ambil
secukupnya

2



Putar di
Telapak Tangan

3



Punggung
Tangan

4



Sela-Sela Jari

5



Punggung Jari
Sampai Ke Sela-Sela

6



Ibu Jari Secara
Berputar

7



Ujung Jari
Berputar



20 - 30
Detik

8



Bilas dengan
Air Mengalir

9



Keringkan
dengan Tisu

10



Tutup Kran
dengan Tisu



30 - 60
Detik

8



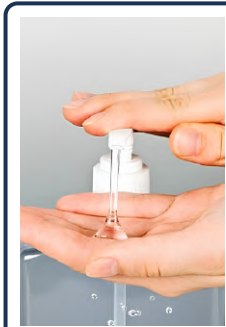
Tangan
Sudah Aman

11



Tangan
Sudah Aman

CARA PEMAKAIAN APD



1 **Lakukan Kebersihan Tangan**



2 **Memakai Gaun / Apron**



3 **Memakai Masker**



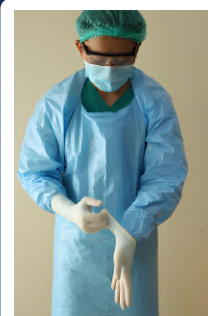
4 **Memakai Kacamata (Google)**



5 **Memakai Tutup Kepala**

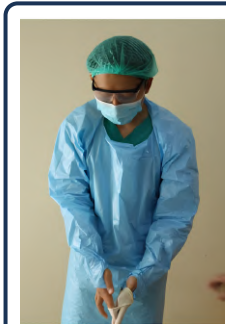


6 **Memakai Pelindung Kaki Khusus**



7 **Memakai Sarung Tangan**

CARA MELEPAS APD



1

Melepas Sarung Tangan



2

Melepas Tutup Kelapa



3

Melepas Kacamata (Google)



4

Melepas Masker



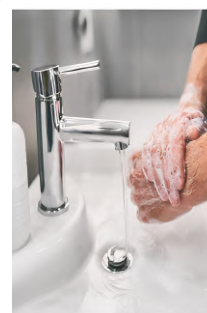
5

Melepas Gaun/Apron



6

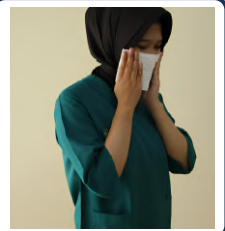
Melepas Pelindung Kaki Khusus



7

Lakukan Kebersihan Tangan

ETIKA BATUK



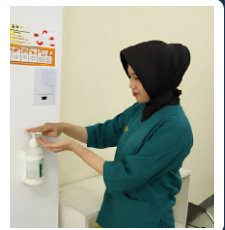
1

Tutup Mulut dan Hidung Anda dengan Tisu Ketika Batuk dan Bersin



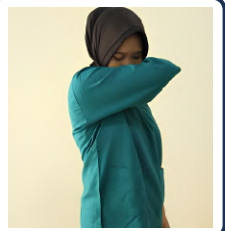
2

Buang Tisu ke Dalam Tempat Sampah Tertutup



3

Lakukan Cuci Tangan dengan Cairan Alkohol / Sabun serta Air Mengalir



4

Jika Tidak Membawa Tisu, Gunakan Lengan Atas Bagian Dalam Untuk Menutup Hidung dan Mulut



5

Jika Anda Flu dan Batuk, Gunakan Masker agar Tidak Mengganggu Orang Lain

SPILL KIT

Spill Kit adalah seperangkat alat yang digunakan untuk menangani jika terjadi tumpahan darah / cairan tubuh, bahan-bahan berbahaya seperti bahan kimia, bahan infeksius, logam berat atau minyak agar tidak membahayakan pasien, keluarga pasien maupun petugas kesehatan.

FUNGSI

Melindungi pasien maupun tenaga kesehatan dari bahaya infeksi nosokomial akibat / dari tumpahan darah atau cairan tubuh.



SPILL KIT

ISI SPILKIT

- | | |
|-------------------------|---|
| 1 Sarung Tangan | 9 Larutan Detergen |
| 2 Masker | 10 Air Bersih |
| 3 Gaun Anti Air (Apron) | 11 Kantong Plastik Kuning
(Untuk Tumpahan Infeksius) |
| 4 Kaca Mata / Google | 12 Kantong Plastik Cokelat
(Untuk Tumpahan B3) |
| 5 Sepatu Boot | 13 Skop dan Sapu Kecil |
| 6 Penutup Kepala | 14 Alat Penyerap |
| 7 Bayclin | |
| 8 Larutan Clorin 0,5% | |

CARA PENGGUNAAN SPILKIT

- 1 Gunakan APD Sesuai Kebutuhan
- 2 Serap Darah atau Cairan Infeksius / Tumpahan B3 dengan Alat Penyerap
- 3 Buang Alat Penyerap ke dalam Kantong Plastik Kuning / Cokelat
- 4 Semprot atau Tuangkan Larutan Clorin 0,5% ke Tempat Tumpahan
- 5 Serap atau Lap dengan Alat Penyerap
- 6 Buang Alat Penyerap ke Kantong Plastik Kuning / Cokelat
- 7 Semprot atau Tuangkan Larutan Detergen ke Tempat Tumpahan
- 8 Serap atau Lap dengan Alat Penyerap
- 9 Buang Alat Penyerap di Kantong Plastik Kuning / Cokelat
- 10 Bila Tumpahan B3, Cukup Menggunakan Air Bersih
- 11 Lepas APD dan Rapikan Alat-Alat
- 12 Cuci Tangan

JENIS PAJANAN

LUKA TUSUK

- 1 Bilas air mengalir dan sabun antiseptik selama 1-3 menit
- 2 PERHATIAN!! Jangan dihisap dan atau ditekan-tekan
- 3 Desinfeksi luka dan daerah sekitar kulit dengan salah satu:
 - Povidon Iodin 2,5%
 - Alkohol 70% selama 3 menit

PAJANAN MUKOSA MATA

- 1 Irigasi dengan PZ selama 15 menit

PAJANAN MUKOSA HIDUNG

- 1 Hembuskan keluar dan bersihkan dengan air bersih selama 1-3 menit

PAJANAN MUKOSA MULUT

- 1 Segera ludahkan dan kumur dengan air bersih selama 1-3 menit

ALUR PENATALAKSANAAN PASCA PAJANAN

FASE 1

- 1 Tindakan dalam fase satu harus dapat dikerjakan oleh semua petugas kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk
- 2 Kejadian harus dilaporkan kepada Dokter Jaga IGD

FASE 2

- 1 Menentukan perlu tidaknya Profilaksis Pasca Pajanan dan Tindakan selanjutnya.
- 2 Dokter Jaga melapor kepada TIM PENANGANAN PASCA PAJANAN
- 3 Fase 1 dan 2 diselesaikan dalam waktu < 4 jam

FASE 3

Pelaporan:

- 1 Kepala ruangan/Instalasi/Unit/Kepala Tim yang bertugas pada saat kejadian mengisi formulir pasca pajanan. Form yang diisi diserahkan kepada PPI.
- 2 Fase 3 diselesaikan dalam waktu < 48 jam

HAK PASIEN DAN KELUARGA

Sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan

Hak Pasien (Pasal 276)

- 1 Mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya.
- 2 Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- 3 Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu.
- 4 Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah.
- 5 Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis.
- 7 Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu.
- 8 Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah.

KEWAJIBAN PASIEN DAN KELUARGA

Sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan

Kewajiban Pasien (Pasal 277)

- 1 Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
- 2 Mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- 3 Mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan
- 4 Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun 2018 Pasal 26 Tentang Kewajiban Pasien

Dalam menerima pelayanan dari Rumah Sakit, Pasien mempunyai kewajiban:

- 1 Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
- 2 Menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggung jawab.
- 3 Menghormati hak pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta Petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit.
- 4 Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya.
- 5 Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya.
- 6 Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7 Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya, dan
- 8 Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

TATA TERTIB

KEWAJIBAN



Penunggu wajib memiliki kartu penunggu pasien yang dapat diambil di Ruang Security dan tidak dipungut biaya.



Dimohon pasien dan keluarga tidak membawa barang berharga. Bila membawa harap disimpan di tempat yang aman karena pihak Rumah Sakit tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan barang.



Tidak diperbolehkan membawa tikar, karpet, kasur, bantal, guling, selimut, senjata tajam, maupun senjata api. Petugas bagian keamanan berhak mengamankan barang tersebut dan akan dikembalikan saat pasien pulang.



Ruang bersalin dan ruang anak pada malam hari penunggu harus wanita.



Pasien remaja dan dewasa yang menunggu adalah sejenis (laki-laki ditunggu laki-laki, perempuan ditunggu perempuan) kecuali yang ada di ruangan tersendiri.



Bila pasien ditunggu oleh keluarganya hanya diperbolehkan satu orang, kecuali pada pasien yang gawat.



Setiap penunggu pasien selama di Rumah Sakit kartu penunggu harus dibawa.

LARANGAN



Tidak diperkenankan tidur di tempat tidur yang kosong, dan tidur bersama dalam satu bed (penunggu dan pasien).



Dilarang merokok di area manapun dalam lingkungan Rumah Sakit.



Membuang sampah pada tempatnya dan dilarang meludah sembarangan.



Bila ada kesulitan yang terkait dengan pasien yang ditunggu, mohon segera lapor ke perawat jaga.



Berilah informasi kepada perawat bilamana menemukan hal yang mencurigakan.



Jam Berkunjung:
PAGI pukul 10.00 WIB - 13.00 WIB
SORE pukul 17.00 WIB - 21.00 WIB



Khusus pasien ICU dan NEONATUS tidak boleh ditunggu di dalam ruang perawatan.



Pasien tidak diperkenankan memakai perhiasan serta membawa atau menyimpan barang berharga selama menjalani perawatan. **Kehilangan atau kerusakan barang bukan menjadi tanggung jawab Rumah Sakit.**



Pasien, Penunggu, Pengunjung dihimbau untuk menjaga ketenangan, kebersihan serta ketertiban di lingkungan Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk.



Anak di bawah usia 12 tahun tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruang perawatan. Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien).



Penunggu pasien diharapkan menjaga kondusifitas dan menunjang proses penyembuhan pasien dengan sikap saling menghargai dan tidak mengganggu pasien lain.

INDIKATOR NASIONAL MUTU RUMAH SAKIT

Tolak Ukur digunakan untuk Menilai Tingkat Keberhasilan Mutu Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- 1 Untuk menilai apakah upaya yang telah dilakukan dapat meningkatkan keluaran pelayanan kesehatan
- 2 Memberikan **umpan balik** kepada fasyankes
- 3 Kepentingan transparansi publik
- 4 Untuk pembelajaran menggunakan praktik terbaik yang diperoleh melalui proses **kaji bandling**

INDIKATOR NASIONAL MUTU RUMAH SAKIT

- 1 Kepatuhan Kebersihan Tangan
- 2 Kepatuhan Penggunaan APD
- 3 Kepatuhan Identifikasi Pasien
- 4 Waktu Tanggap *SC Emergency*
- 5 Waktu Tunggu Rawat Jalan
- 6 Penundaan Operasi Elektif
- 7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter Spesialis
- 8 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium
- 9 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
- 10 Kepatuhan Terhadap *Clinical Pathway*
- 11 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
- 12 Kecepatan Waktu Tanggap Komplain
- 13 Kepuasan Pasien dan Keluarga

INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT KERJA

KEBIJAKAN

Kepala unit kerja berpartisipasi dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dengan melakukan pengukuran indikator mutu rumah sakit yang dapat diterapkan di unitnya dan memantau serta memperbaiki pelayanan pasien di unit layanannya/unit kerjanya.

Setiap unit kerja wajib memilih dan menetapkan indikator mutu unit kerjanya, dibantu/difasilitasi oleh Komite Mutu. Pemilihan indikator unit kerja memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Prioritas pengukuran mutu pelayanan klinis di rumah sakit. Indikator mutu yang dipergunakan untuk mengukur mutu di prioritas pengukuran mutu rumah sakit, sumber data pasti dari unit, dan menjadi indikator mutu unit;
- Fokus mengukur hal-hal yang ingin diperbaiki;
- Melakukan koordinasi dengan komite medis bila evaluasi penerapan panduan praktik klinis dan evaluasi kinerja dokter menggunakan indikator mutu;

MAKSUD & TUJUAN

Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP-Unit) untuk:

- 1 Mengurangi Variasi
- 2 Meningkatkan Keselamatan pada Prosedur / Tindakan Beresiko Tinggi
- 3 Meningkatkan Kepuasan Pasien
- 4 Efisiensi Sumber Daya

AREA PRIORITAS PERBAIKAN RUMAH SAKIT

KRITERIA PEMILIHAN PRIORITAS

Masalah yang paling banyak di RS

Jumlah yang banyak

Proses Beresiko Tinggi

Ketidakpuasan Pasien dan Staf

Kemudahan dalam Pengukuran

Ketentuan Pemerintah

Sesuai dengan Tujuan Strategis RS

Memberi Pengalaman Pasien yang Lebih Baik



AREA PELAYANAN KLINIS

Pelayanan Hemodialisa

merupakan pelayanan rawat jalan yang *high volume, high risk, high cost*.

Pelayanan *Obsterty Ginrcology*

salah satu dari 10 daftar pelayanan prioritas. Berdasarkan SE Kemenkes.

Pelayanan *Orthopedy*

berdasarkan data *survelance* HAI's 2025, terjadi beberapa kali ILO terkait pelayanan *orthopedy*.



**DILAKUKAN DENGAN
SISTEM SKORING**

**Terpilih skor tertinggi:
PELAYANAN ORTHOPEDY**

INDIKATOR MUTU PRIORITAS RUMAH SAKIT TAHUN 2026

SASARAN KESELAMATAN PASIEN

Kelengkapan
Pengisian Identitas
Pasien pada e-RM

SKP 1
Rekam
Medis

Kepatuhan
Pelaksanaan
Dokumentasi SBAR
pada E-RM

SKP 2
Ranap &
IGD

Kepatuhan
Penyimpanan dan
Pelabelan Obat
High Alert

SKP 3
Farmasi

Pelaksanaan
Surgical Safety
(SSC) pada Bedah
Orthopedy

SKP 4
OK

Kepatuhan
Kebersihan Tangan
Petugas Kesehatan
Kamar Bedah

SKP 5
IPCN

Kejadian Pasien
Jatuh

SKP 6
Mutu

PELAYANAN KLINIS PRIORITAS

PPI

Jumlah Kejadian ILO
pada Pasien Bedah
Tulang (*Orthopedy*)

TUJUAN STRATEGIS RUMAH SAKIT

IGD

Persentase Kematian
Pasien IGD < 24 jam

PERBAIKAN SISTEM

**Rekam
Medis**

Kepatuhan
Penggunaan
Mobile JKN

MANAJEMEN RESIKO

CSSD

Kepatuhan Proses
Sterilisasi Instrumen
Bedah Orthopedi
Sesuai Standar PPI

PENGKAJIAN NYERI

1

NUMERIC RATING SCALE



0 = Tidak Nyeri

1 - 3 = Nyeri Ringan
(Sedikit Mengganggu Aktivitas Sehari-Hari)

Nyeri Sedang
4 - 6 = (Gangguan Nyata Terhadap Aktivitas Sehari-Hari)

Nyeri Berat
7 - 10 = (Tidak Dapat Melakukan Aktivitas Sehari-Hari)

Indikasi digunakan pada pasien dewasa dan anak berusia > 9 tahun yang dapat menggunakan angka untuk melambangkan intensitas nyeri yang dirasakannya.

Instruksi pasien akan ditanya mengenai intensitas nyeri yang dirasakan dan dilambangkan dengan angka antara 0 – 10.

PENGKAJIAN NYERI

2 WONG BAKER FACES PAIN SCALE

WONG-BAKER FACES PAIN SCALE

Pilih wajah yang paling menggambarkan tingkat nyeri yang Anda rasakan



INDIKASI

Pada pasien (dewasa dan anak > 3 tahun) yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka.

INSTRUKSI

1. Tunjukkan gambar-gambar mimik wajah yang ada pada skala nyeri kepada anak.
2. Beri penjelasan secara singkat mengenai tingkat rasa nyeri yang diwakili setiap gambar.
3. Mintalah anak untuk memilih gambar yang paling menggambarkan rasa nyeri yang dirasakannya.
4. Cocokkan dengan skala angka pada gambar.

CONTOH

Jelaskan pada anak bahwa anak dapat memilih wajah nomor 0 bila anak tidak merasakan sakit sama sekali, wajah 1 bila anak hanya sedikit merasakan sakit, Wajah 2 bila lebih sakit, wajah 3 bila jauh lebih sakit. Wajah 4 bila sangat sakit tapi tidak sampai menangis, wajah 5 bila sangat sakit sampai menangis.

PENGKAJIAN ULANG NYERI

Khusus untuk pasien rawat inap dilakukan juga asesmen ulang terhadap penilaian nyeri, asesmen ulang ini dilakukan dengan interval tertentu yang teratur, yaitu :

- Pemberian parenteral 30 menit berikutnya
- Pemberian oral: 60 menit berikutnya
- Intervensi non-farmakologi 30-60 menit berikutnya



KOMUNIKASI PERAWAT DALAM PENGKAJIAN NYERI

SALAM

"Selamat pagi, pak / bu? Perkenalkan nama saya, saya perawat di ruang....."

EVALUASI / VALIDASI

"Apakah bapak / ibu saat ini masih merasakan nyeri?"

KONTRAK (TOPIK, WAKTU, DAN TEMPAT)

"Saat ini saya akan menanyakan tentang skala nyeri yang ibu rasakan."

TUJUAN

Menanyakan skala nyeri bertujuan untuk mengetahui respon / efektifitas pengobatan yang telah dilakukan dan sebagai dasar untuk melakukan tindakan / pengobatan yang selanjutnya.

FASE KERJA

"Bapak/ ibu, bila penilaian skala nyeri digambarkan dengan angka 1 s/d 10; 1-3 adalah nyeri ringan, 4-6 adalah nyeri sedang dan 7-10 adalah nyeri berat, maka nyeri yang ibu rasakan berada pada angka berapa?"

TERMINASI

"Bagaimana perasaan ibu setelah memberitahukan skala nyeri ibu?"

RENCANA TINDAK LANJUT

- Ibu, dari hasil evaluasi ibu masih merasakan nyeri berat.
- Tindakan yang bisa dilakukan adalah melakukan kompres hangat dan melakukan distraksi relaksasi.
- Baiklah kalau begitu saya akan mengkonsultasikan keluhan ibu kepada dokter penanggung jawab.

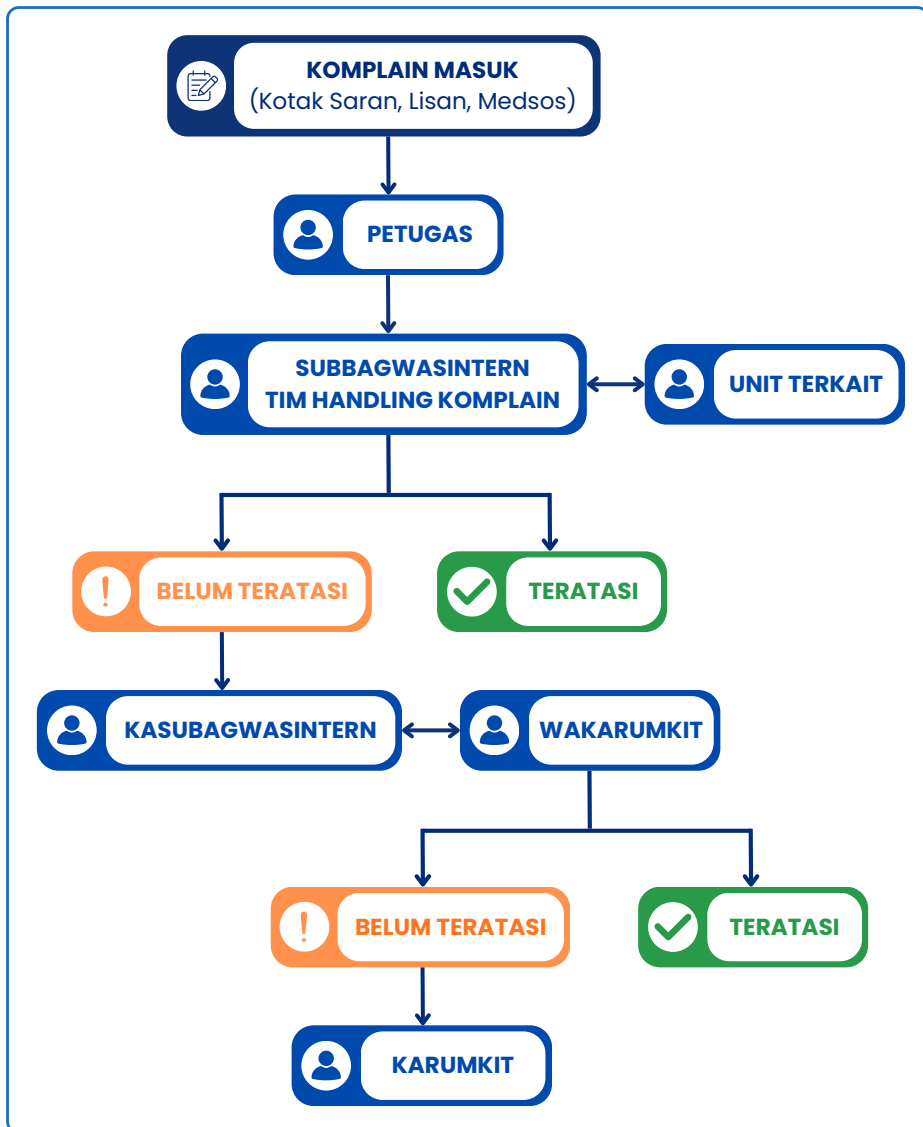
KONTRAK YANG AKAN DATANG

"Ibu nanti siang sekitar jam 12.00 saya akan kembali untuk memberikan obat pereda nyeri, mari bu, selamat pagi."

PROSEDUR MENANGGAPI KOMPLAIN / KELUHAN PASIEN DAN KELUARGA

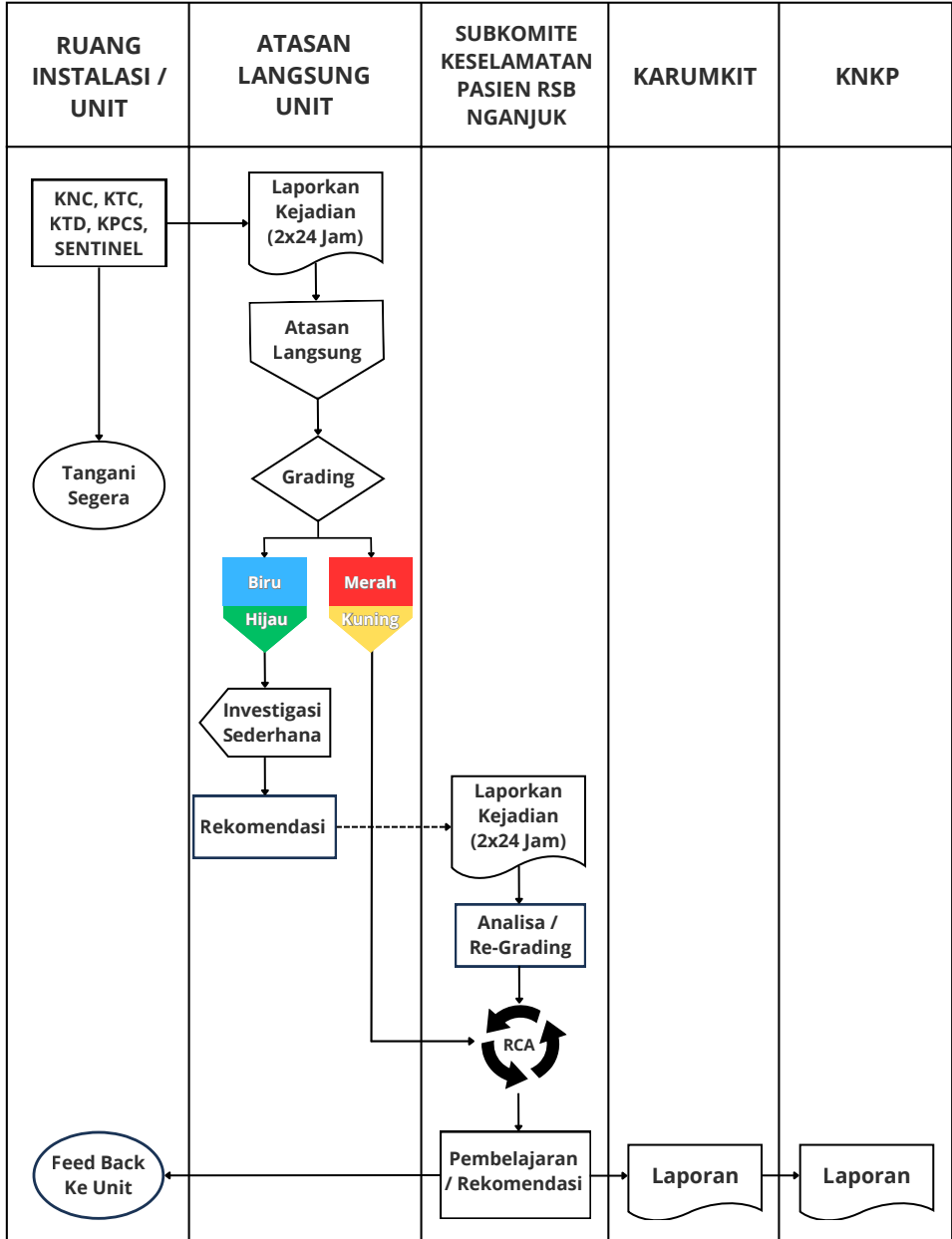
- Keluhan yang disampaikan secara lisan, Staf Rumah Sakit wajib melakukan:
Staf mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh pasien dan keluarga dengan cara:
 - Tenang dan optimis
 - Tidak melakukan adu dengan pasien dan keluarga
 - Tidak memotong atau menyela pembicaraan
 - Upayakan tidak terlibat secara emosional yang mendalam
 - Tidak tertawa saat berbicara dengan pasien dan keluarga
 - Tidak membela diri dan menyudutkan pasien dan keluarga
- Empati kepada pasien dan keluarga
- Mengklarifikasikan keluhan yang disampaikan
- Meminta maaf kepada pasien dan keluarga atas ketidakpuasan yang diterima
- Mencatat setiap keluhan pasien dan keluarga dan melaporkan kepada bagian yang terkait

ALUR KOMPLAIN / KELUHAN PASIEN DAN KELUARGA



ALUR PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN

(Dilaporkan Oleh Petugas / Karyawan yang Pertama Mengetahui Insiden)



PROSEDUR EVAKUASI

BILA TERJADI KEBAKARAN



TETAP TENANG

Jangan panik dan jangan berlari.



IKUTI ARAHAN

Ikuti petunjuk arah / arahan dari petugas evakuasi.



JANGAN MEMBAWA BARANG

Jangan mencoba mengambil barang yang tertinggal.



LEPASKAN SEPATU HAK TINGGI

Lepaskan sepatu hak tinggi.



GUNAKAN TANGGA / PINTU DARURAT

Gunakan tangga / pintu darurat terdekat menuju jalur evakuasi.



JALAN MERANGKAK

Jalan merangkak menuju tangga / pintu darurat bila lorong dipenuhi asap.



TUTUP HIDUNG DAN MULUT

Tutup hidung dan mulut dengan saputangan atau tissue yang telah dibasahi air.



TITIK KUMPUL

Keluar menuju titik berkumpul terdekat.

BILA TERJADI GEMPA



TETAP TENANG

Jangan panik.



BERLINDUNG

Segera berlindung di bawah meja atau tempat tidur jika ada. Jika tidak ada, bisa bersandar di tembok dengan posisi tangan di atas kepala.



JIKA GEMPA SEMAKIN HEBAT

Segera berlari ke titik berkumpul terdekat dengan posisi tangan di atas kepala untuk melindungi kepala kita dari reruntuhan.

JIKA TERJADI KEBAKARAN, YANG DILAKUKAN

PETUGAS DI TEMPAT KEJADIAN

1



LAPOR SEGERA

Hubungi **123**, sebutkan **"CODE RED"** sebanyak 3 kali. Sebutkan lokasi kejadian dengan format: "Lokasi..., Lantai...".

ULANGI INFORMASI

Ulangi sampai 2 kali.

Contoh :

"Code Red, Code Red, Code Red di Ruang Dahlia Lantai 3"

Ulangi sampai 2 kali.

2



PADAMKAN API

Sambil menunggu bantuan datang, ambil APAR terdekat dan lakukan pemadaman api dengan cara **TATS**.

3



SATPAM MENGAKTIFKAN ALARM

Satpam menyalakan sirene central dan menginformasikan **CODE RED** di lokasi kejadian kebakaran.

4



AMANKAN LISTRIK

Penemu kedua segera matikan panel listrik di lokasi kejadian kebakaran.

5



EVAKUASI (JIKA KEBAKARAN MELUAS)

Ketua TIM Tanggap Darurat menghubungi DAMKAR dan segera melakukan evakuasi.

6



IKUTI JALUR EVAKUASI

- Menjauhi titik api menuju titik kumpul di halaman parkir depan dan belakang.
- Jalur evakuasi sesuai dengan peta.

WARNA HELM PETUGAS EVAKUASI



SATPAM

Menangani kebakaran dengan menggunakan APAR



KATIM

Menangani evakuasi pasien



PEKARYA

Menangani evakuasi dokumen penting



CS / TRANSPORTER

Menangani evakuasi alat medis

PETUNJUK PENGGUNAAN APAR



CARA MENGGUNAKAN APAR

METODE TATS



TARIK

TARIK SAFETY PIN



ARAHKAN

ARAHKAN CORONG KE
TITIK / DASAR API



TEKAN

TEKAN TUAS APAR
SAMPAI GAS KELUAR



SAPUKAN

SAPUKAN DARI SISI KE
SISI DENGAN JARAK 2
METER DAN TIDAK
MELAWAN ARAH ANGIN



INGAT!

Gunakan APAR hanya bila api masih kecil dan kondisi memungkinkan. Jika api membesar / tidak terkendali, segera **EVAKUASI** dan **HUBUNGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN**.

BANTUAN HIDUP DASAR (BHD)

PENGERTIAN

Suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah proses akut (henti jantung, henti nafas, hipofentilasi, kehilangan darah) menuju kematian klinis (mati suri = otak berhenti berfungsi sementara) dan kematian seluler / biologis (kerusakan otak dan organ vital secara ereversible).

TUJUAN

- Mampu melakukan resusitasi jantung dan paru dengan benar
- Mampu mendiagnosa henti jantung
- Mampu membebaskan jalan napas
- Mampu memberikan napas buatan

PROSEDUR

JARGON : **3 A CEPAT TEPAT RAKA BANA REK**

- **3 A** : AMAN DIRI, PASIEN, DAN LINGKUNGAN
- **CE** : CEK KESADARAN
- **PA** : PANGGIL BANTUAN
- **T** : TELENTANGKAN PASIEN
- **TE** : TENGADAHKAN KEPALA
- **PA** : CEK NAPAS
- **T** : TEKAN DADA / JANTUNG

BANTUAN HIDUP DASAR (BHD)

1 CARA PIJAT JANTUNG

Lakukan pijat jantung:

- Tekan dengan keras dan cepat
- Kecepatan pijatan 100x/menit dan kedalaman tekanan $\pm$ 4-5 cm

Dengan hitungan

- Satu, dua, tiga, empat - **SATU**
- Satu, dua, tiga, empat - **DUA**
- Satu, dua, tiga, empat - **TIGA**
- Satu, dua, tiga, empat - **EMPAT**
- Satu, dua, tiga, empat - **LIMA**
- Satu, dua, tiga, empat - **ENAM**

2 CEK JALAN NAPAS

Ada hambatan / benda asing

- Lakukan *finger swab* untuk mengeluarkan benda asing

Jalan napas bebas

- Atur posisi kepala *head tilt, chin lift / jaw thrust*

Lakukan bantuan napas 2x hembusan sambil lihat pergerakan / pengembangan rongga dada

3 TOTAL DALAM SIKLUS

30 kali pijatan diikuti dengan 2 kali bantuan napas

BANTUAN HIDUP DASAR (BHD)

4 RAKA : RABA NADI KAROTIS

Cek nadi carotis tiap 5 siklus / setiap 2 menit

Nadi Carotis Teraba

- Posisikan korban miring ke kanan / posisi mantab / stabil / *recovery position*

Nadi Carotis Tidak Teraba

- Lakukan RJP sampai pertolongan datang / penolong lelah

5 BANA : BANTUAN NAPAS

6 REK : POSISI RECOVERI

Hentikan pijat jantung ketika sudah ada tanda-tanda aktifitas jantung / penolong sudah kelelahan / dalam 30-45 menit dilakukan resusitasi tidak ada tanda-tanda aktifitas jantung.

6 SASARAN KESELAMATAN PASIEN

- 1 Ketepatan Identifikasi Pasien Sasaran
- 2 Peningkatan Komunikasi yang Efektif Sasaran
- 3 Peningkatan Keamanan Obat yang perlu di Waspadai (*High Alert Medication*)
- 4 Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, dan Tepat Pasien Operasi Sasaran
- 5 Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan
- 6 Pengurangan Risiko Cedera Akibat Pasien Jatuh

KODE ETIK PEGAWAI

Merupakan pedoman perilaku bagi pegawai Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk dalam melaksanakan tugas:

1

Setiap pegawai Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi dan mematuhi Sumpah Jabatan dan Sumpah Pegawai, serta melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan;

2

Setiap pegawai Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk melaksanakan tugasnya secara Profesional dengan mengutamakan keluhuran Budi dan Keunggulan Kualitas, menggunakan kemampuan secara Arif dan Bijaksana, Jujur, Bertanggungjawab, dan Berintegritas Tinggi serta dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3

Setiap pegawai Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk melaksanakan tugasnya tanpa Diskriminasi, dengan mewujudkan kesetaraan perlakuan, menghargai Hak Asasi Manusia, dan Peduli pada masyarakat dan lingkungan;

4

Setiap pegawai Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;

5

Setiap pegawai Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;

6

Setiap pegawai Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, dan standar pelayanan yang berlaku;

7

Setiap pegawai Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk melaksanakan tugasnya berhak mendapatkan kesempatan untuk pengembangan kompetensi;

KODE ETIK PEGAWAI

- 8 Setiap pegawai Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien;
- 9 Setiap pegawai Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- 10 Setiap pegawai Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk menjaga kerahasiaan yang menyangkut kerahasiaan pasien dan kebijakan negara;
- 11 Setiap pegawai Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- 12 Setiap pegawai Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk tidak menyalahgunakan informasi intern terkait tugas, status, dan jabatan untuk mendapat / mencari keuntungan / manfaat bagi diri sendiri / untuk orang lain;
- 13 Setiap pegawai Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Standar Pelayanan, serta Kode Etik, dan Pedoman Perilaku pegawai Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang ada;
- 14 Setiap pegawai Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan sesuai dengan prestasi dan dedikasi kerja pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk;
- 15 Setiap pegawai Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk memegang teguh kode etik dan selalu menjaga citra dan nama baik Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk.